

2025 年 09 月 02 日

投资评级：看好（维持）

证券分析师

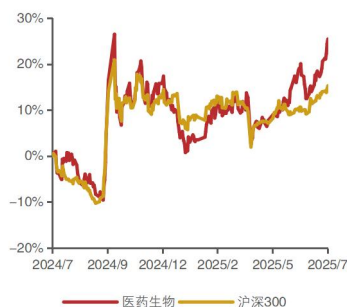
刘闯

SAC: S1350524030002

liuchuang@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



人福医药：创新管线有哪些？

——医药行业周报（25/8/25-25/8/29）

投资要点：

- 本周医药市场表现分析：**8月25日至8月29日，医药指数下跌0.65%，相对沪深300指数超额收益为-3.37%。本周，天臣医疗、艾力斯、迈威生物-U等公司涨幅居前，医疗服务本周涨幅靠前，继续重点看好创新药，关注下半年有BD强催化的核心标的。建议关注：1）创新药作为较为确定的产业趋势，重点关注：A股）热景生物、华纳药厂、微芯生物、悦康药业、前沿生物、福元医药、昂利康、信立泰、一品红、科兴制药、泽璟制药、科伦药业、恒瑞医药；港股）三生制药、中国生物制药、科伦博泰、康方生物、信达生物、翰森制药；2）25年业绩或逐季度边际改善、估值水平较低且有边际改善的个股，建议关注CXO及产业链（药明康德、泰格医药、百普赛斯等）、昆药集团、马应龙、开立医疗、迈瑞医疗、鱼跃医疗、海泰新光、麦澜德等；3）集采边际改善板块：医疗耗材（南微医学、微电生理、爱博医疗、心脉医疗等），药品（人福医药、恩华药业等）。
- 医药指数和各细分领域表现、涨跌幅：**本周上涨个股数量101家，下跌个股385家，涨幅居前为天臣医疗（+31.04%）、艾力斯（+25.62%）、迈威生物-U（+22.39%）、万邦德（+21.97%）、透景生命（+18.91%），跌幅居前为立方制药（-13.93%）、悦康药业（-11.90%）、康华生物（-11.14%）、辰欣药业（-11.10%）、皓宸医疗（-10.93%）。
- 人福医药创新管线已具规模，大股东赋能下研发有望提速，看好公司从麻醉药龙头向综合性医药研发龙头转型。**人福医药为国内老牌Pharma，坚持多年高研发投入，2021年开始每年研发支出超过10亿元，2020-2024年5年研发支出合计达到63.0亿元，2024年公司研发支出达到16.3亿元，占公司营业收入（扣除商业）的比例达到11.4%。截止2024年，公司共有在研项目500多个，其中1、2类创新药项目60多个，目前进入临床阶段的研发管线已经较为丰富：1）**从治疗领域看**，研发管线从传统优势麻醉镇痛领域向呼吸、癌症、自免和慢性病等多领域拓展；2）**从靶点创新来看**：在麻醉镇痛领域，公司布局外周κ阿片受体抑制剂（临床二期）、Sigma-1受体特异性拮抗剂（临床一期）、电压门控钠离子通道抑制剂（临床一期）、钠离子通道阻断剂（临床一期）等多个创新靶点，不断强化公司在镇痛领域竞争力。在肿瘤领域，公司布局SOS1抑制剂（临床一期）、EP4抑制剂（临床一期）以及anti-FGFR2b单抗（获批临床）等靶点，进军广阔肿瘤市场。此外，积极布局ATX抑制剂（肺纤维化适应症，临床二期）、15-PGDH抑制剂（炎症性肠病适应症，临床一期）、P2X3拮抗剂（慢性咳嗽，临床一期）等创新靶点，打开公司长期成长天花板；3）**从临床进度来看**，公司多个早研产品处于第一梯队，如重组质粒-肝细胞生长因子注射液为国内第二报产，其他管线如ATX抑制剂、15-PGDH抑制剂和SOS1抑制剂等多个产品研发进度处于国内前三。总体来看，人福医药经过多年研发投入，目前创新管线规模已经显现，随着后续央企大股东招商局在创新方面给人福医药带来的赋能，我们认为公司的创新研发有望加速、研发效率有望提高，我们看好未来人福医药在创新管线方面有望持续取得积极进展，带动公司从麻醉药龙头向综合性医药研发龙头转型。
- 投资观点及建议关注标的：**展望2025年，我们认为医药板块已经具备多方面的积极发展因素，基本完成了新旧增长动能转换（创新替代仿制，出海能力提升），创新药打开中国医药企业增长新曲线，具体来看，1）国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，恒瑞医药、翰森制药、科伦药业等传统pharma已完成创新的华丽转身，百利天恒、科伦博泰、康方生物等创新药公司正在以全球First-in-class的姿态快速崛起；2）出海能力持续提升，创新药械的BD持续创纪录，中国企业已成为全球MNC非常重视的创新转换来源。医疗设备、供应链等已在全球范围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角，如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造等；3）老龄化持续加速，心脑血管、内分泌、骨科等慢性疾病需求持续提升，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械、制造出海（CXO及科研上游、供

应链、器械及高端制剂）、国产替代（设备和高值耗材）、老龄化及院外消费（家用器械、中药等）、高壁垒行业（血制品、麻药），关注估值相对低位医药资产估值修复机会。

- **本周建议关注组合：**信立泰、上海谊众、前沿生物、热景生物、中国生物制药；
- **九月建议关注组合：**恒瑞医药，信立泰，科伦药业，康弘药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，三生制药，上海谊众，前沿生物。
- **风险提示：**行业竞争加剧风险，政策变化风险，行业需求不及预期风险。

内容目录

1. 人福医药：创新管线有哪些？	5
1.1. 基因疗法产品已报产，掘金广阔慢病市场	6
1.2. 前瞻布局镇痛创新靶点，护城河不断拓宽	8
1.3. 布局肺纤维化新靶点，竞争格局好	9
1.4. 布局 15-PGDH 创新靶点，拓展炎症性肠病	10
1.5. P2X3 拮抗剂临床推进，布局难治性慢性咳嗽	11
1.6. 多款新靶点临床推进中，进军肿瘤广阔市场	12
2. 行业观点：坚持创新药作为全年主线，关注制造出海+老龄化消费等估值相对低位资产	13
3. 风险提示	19

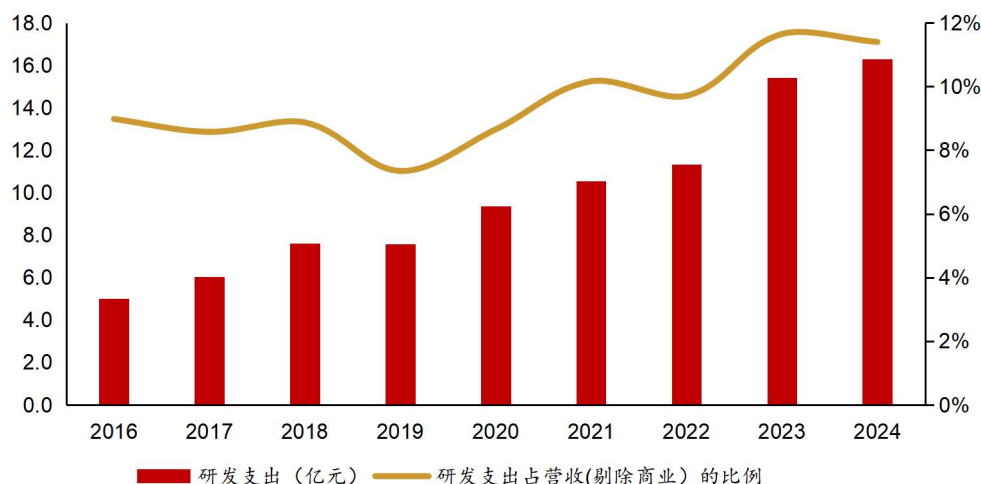
图表目录

图表 1： 人福医药 2016–2024 年研发支出以及占比	5
图表 2： 人福医药部分创新药在研管线情况	6
图表 3： 严重下肢缺血治疗流程	7
图表 4： 中国针对 HGF 靶点的进入临床管线情况	7
图表 5： PUDK–HGF 二期临床疼痛缓解率对比	8
图表 6： PUDK–HGF 二期临床溃疡面积改善对比	8
图表 7： 阿片类镇痛药受体分类	9
图表 8： 高效低毒阿片类镇痛药研发思路	9
图表 9： Autotaxin 作用机制	10
图表 10： 目前 Autotaxin 抑制剂药物竞争格局（截至 2025 年 8 月）	10
图表 11： HW201877 作用机制	11
图表 12： P2X3 影响咳嗽机制	11
图表 13： 人福医药专利 P2X3 拮抗剂分子结构	12
图表 14： 默沙东 gefapixant 分子结构	12
图表 15： 人福医药 P2X3 拮抗剂临床前疗效	12
图表 16： 目前 anti–FGFR2b 单抗药物竞争格局（截至 2025 年 8 月）	13
图表 17： 目前 SOS1 抑制剂药物竞争格局（截至 2025 年 8 月）	13
图表 18： 本周申万医药行业涨幅 Top10	13
图表 19： 本周申万医药行业跌幅 Top10	14
图表 20： 2024 年初至今医药指数表现	14
图表 21： 申万各板块年初至今涨跌幅情况	15
图表 22： 年初至今医药子板块涨跌幅情况	15
图表 23： 本周医药子板块表现情况	15
图表 24： 申万各板块 PE 估值情况（截至 2025 年 8 月 29 日，整体 TTM 法）	16
图表 25： 申万医药及沪深 300 PE 估值情况（截至 2025 年 8 月 29 日，整体 TTM 法）	16
图表 26： 申万医药各细分板块 PE 估值情况（截至 2025 年 8 月 29 日，整体 TTM 法）	17
图表 27： 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例（万亿）	17

1. 人福医药：创新管线有哪些？

人福医药坚持多年高研发投入,研发支出2016年的5.02亿元增长至2024年的16.30亿元,年复合增长率达15.8%。剔除医药商业收入(医药批发等业务)后,研发支出占营收比重从2016年的8.98%提升至2024年的11.40%,近五年累计投入超62亿元。

图表 1：人福医药 2016-2024 年研发支出以及占比



资料来源：Wind，华源证券研究所

公司已经形成较为丰富的创新研发管线，疾病领域涉及麻醉镇痛、癌症、呼吸及慢性病等多个疾病领域，进展较快如重组质粒-肝细胞生长因子（pUDK-HGF），其关于严重下肢缺血性疾病导致的肢体静息痛已于2024年12月申报上市。

此外，公司还有多款创新药处于临床各个阶段：HWH486（BTK抑制剂，慢性自发性荨麻疹适应症临床二期）、RFUS-144（opioid receptor 激动剂，镇痛适应症临床二期，止痒适应症临床一期）、HWH340（PARP抑制剂，实体瘤临床二期）、HW021199（autotaxin抑制剂，特发性肺纤维化适应症临床二期）以及多款创新产品处于临床一期阶段。

图表 2：人福医药部分创新药在研管线情况

药品名称	作用机制	疾病	中国最高研发阶段	中国最高研发阶段开始日期
pUDK-HGF	基因疗法	严重肢体缺血;疼痛;周围动脉闭塞性疾病	申请上市	2024-12-04
HWH486	BTK 抑制剂	慢性自发性荨麻疹;类风湿性关节炎	II 期临床	2023-11-20
RFUS-144	opioid receptor 激动剂	术后疼痛;慢性疼痛;急性疼痛;瘙痒症	II 期临床	2024-04-03
HWH340	PARP 抑制剂	去势抵抗前列腺癌;实体瘤;激素敏感性前列腺癌	II 期临床	2022-12-22
HW021199	autotaxin 抑制剂	特发性肺纤维化	II 期临床	2023-08-16
HW071021	SOS1 抑制剂	实体瘤	I 期临床	2025-03-05
HW201877	15-PGDH 抑制剂	溃疡性结肠炎;克罗恩病;炎症性肠病;特发性肺纤维化	I 期临床	2025-06-12
HW091077	P2X3 拮抗剂	慢性咳嗽	I 期临床	2023-12-15
HW060015	EP4 抑制剂	实体瘤	I 期临床	2024-05-17
HW231019	sodium channel 抑制剂	急性疼痛	I 期临床	2025-04-03
RFUS-949	σ 1 receptor 拮抗剂	急性疼痛;慢性疼痛;神经痛	I 期临床	2025-06-18
HW211026	NA	光化性角化病	I 期临床	2025-02-14
RFUS-250	opioid receptor 激动剂	疼痛;瘙痒症;急性疼痛;慢性疼痛	I 期临床	2024-09-04
LL-50	sodium channel 阻断剂	急性疼痛;麻醉相关;麻醉镇痛;局部麻醉	I 期临床	2023-11-03
rhTRAIL	重组 TRAIL	癌症	I 期临床	
CXJM-66	sodium channel 阻断剂	麻醉镇痛;急性疼痛;术后疼痛	I 期临床	2025-03-18
HWS116	anti-FGFR2b 单抗	实体瘤	获批临床	2025-04-21
HW241045	NA	特发性肺纤维化;未知/待定	申报临床	2025-05-22

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

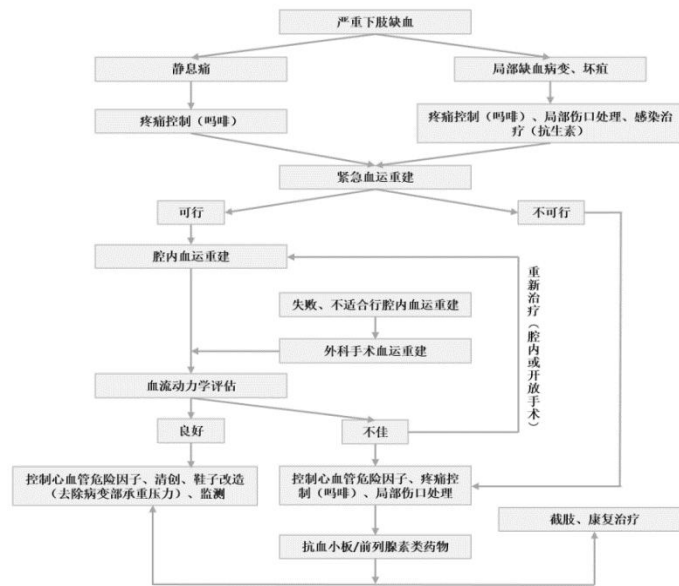
1.1. 基因疗法产品已报产，掘金广阔慢病市场

严重下肢缺血 (Critical limb ischemia, CLI) 是下肢外周动脉疾病 (Peripheral artery disease, PAD) 进展至最为严重的缺血阶段，下肢动脉堵塞限制血液流动，临床表现为行走能力下降、静息痛 (持续 2 周以上) 、溃疡和坏疽，严重影响患者的生活质量，部分患者甚至只能面临截肢或死亡。

根据国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告 2023》，推算目前中国 PAD 患者约 4530 万人，此外根据《基因治疗性血管生成在下肢缺血性疾病中的研究进展》(桂亮等)，在 PAD 患者中约有 10% 患者最终可发展为 CLI，我们预计国内 CLI 人群在数百万量级，且随着人口老龄化以及高血压、高血脂和糖尿病等风险因素的增多，预计下肢缺血患病率正在逐渐上升。

CLI 目前尚无彻底治愈的药物,通过血管腔内介入或外科手术进行血运重建是目前治疗 CLI 的最佳治疗方案。然而《基因治疗性血管生成在下肢缺血性疾病中的研究进展》(桂亮等) 显示，仍有 30% 患者由于高龄、合并疾病等原因不能耐受手术，其他治疗手段如药物治疗 (抗凝药物、血管扩张药物) 仅为对症治疗，此外截肢为最终治疗方式。

图表 3：严重下肢缺血治疗流程



资料来源：《下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》，华源证券研究所

治疗性血管生成通过应用细胞因子或成血管细胞转入缺血组织，转化局部微环境来提供血管生成的环境以促进缺血组织毛细血管网络生成和侧支循环的建立，从而改善缺血区域的血流灌注，为 CLI 治疗带来新思路与策略。

HGF 是一种多功能性细胞因子，其能够在抑制炎症、水肿和细胞衰老的同时发挥促血管生成的作用。HGF 基因疗法目前全球进入临床阶段的候选药物较少，日本 AnGes 公司开发的重组人肝细胞生长因子裸质粒基因治疗药物于 2019 年在日本获得有条件批准，2024 年获得 FDA 突破性疗法认证。国内针对严重肢体缺血的在研药物较少，诺思兰德的塞多明基已经申报上市，人福医药的重组质粒-肝细胞生长因子于 2024 年 12 月上市申请获得受理等。

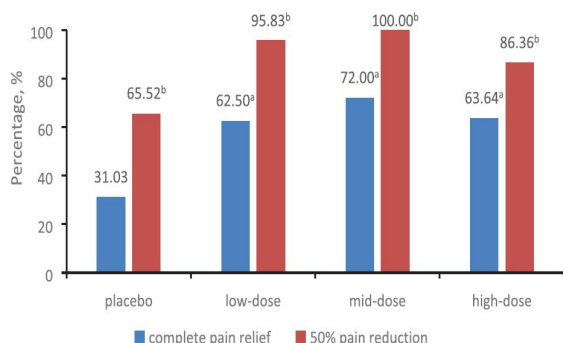
图表 4：中国针对 HGF 靶点的进入临床管线情况

药品名称	靶点	研发机构	作用机制	疾病	中国最高研发阶段	中国最高研发阶段开始日期
塞多明基	HGF	Reyon Pharmaceutica;Kolon TissueGene;诺思兰德;Helixmith	基因疗法	严重肢体缺血;糖尿病周围神经病变;糖尿病足;糖尿病周围神经病;外周动脉疾病;心肌梗塞;肌萎缩侧索硬化症;冠心病;稳定性心绞痛;腓骨肌萎缩症 1A 型	申请上市	2024-07-12
pUDK-HGF	HGF	军科院放射与辐射医学研究所;人福医药	基因疗法	严重肢体缺血;疼痛;周围动脉闭塞性疾病	申请上市	2024-12-04
RGL-2102	HGF	瑞宏迪医药	mRNA 疗法	严重肢体缺血;糖尿病足;肢体缺血性疾病;褥疮	II 期临床	2025-01-09
Ad-HGF	HGF	军科院放射与辐射医学研究所;人福医药	基因疗法	心脏病;冠心病;心肌梗塞	II 期临床	2014-05-07
利妥木单抗	HGF	Astellas Pharma;Amgen	anti-HGF 单抗	胃癌;胃食管交界处癌;鳞状非小细胞肺癌;肾细胞癌;高级别胶质瘤;输卵管癌;卵巢癌;腹膜癌;胸膜间皮瘤;胶质肉瘤;食管癌;胶质母细胞瘤;去势抵抗前列腺癌;小细胞肺癌;结肠癌;直肠癌;非小细胞肺癌;结直肠癌	申报临床	2012-10-30

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

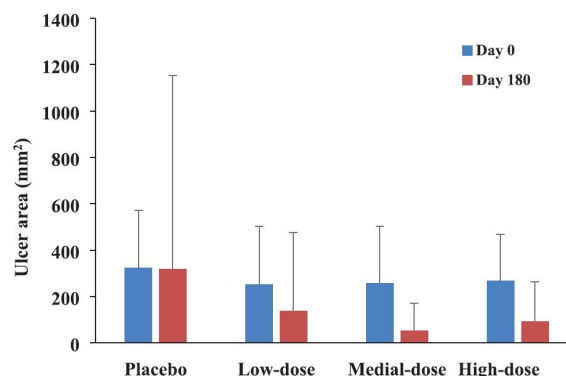
人福医药的重组质粒-肝细胞生长因子注射液（PUDK-HGF）为生物制品 1 类新药，其二期临床数据显示，治疗 180 天后（第 0/14/28 天接受治疗）对比安慰剂，不同剂量组疼痛完全缓解率达到 60–70%，安慰剂组约为 31%；在溃疡患者中，试验组的溃疡面积也显著改善。

图表 5：PUDK-HGF 二期临床疼痛缓解率对比



资料来源：《pUDK-HGF Gene Therapy to Relieve CLI Rest Pain and Ulcer: A Phase II, Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial》. Yongquan Gu, et al, 华源证券研究所

图表 6：PUDK-HGF 二期临床溃疡面积改善对比



资料来源：《pUDK-HGF Gene Therapy to Relieve CLI Rest Pain and Ulcer: A Phase II, Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial》. Yongquan Gu, et al, 华源证券研究所

1.2. 前瞻布局镇痛创新靶点，护城河不断拓宽

在镇痛新药开发领域，靶点主要包括基于阿片受体的疼痛与镇痛靶点（主流方向），阿片类镇痛药由阿片受体家族 4 个亚型介导，即 μ 、 δ 、 κ 和 NOP 受体。其中， μ 阿片受体被公认是镇痛和副作用主要靶点，该受体与药物结合后能激活多条下游信号通路，在产生强效镇痛作用的同时伴随出现过度镇静、呼吸抑制、便秘、耐药、成瘾等不良反应。现阶段，新型阿片类镇痛药物的研发主要集中在三条路线：偏向性激动策略、外周阿片受体激动策略、“一药多靶”策略。

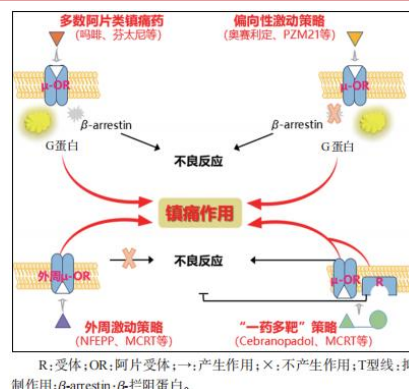
此外如大麻素受体、 $\alpha 2$ 肾上腺素能受体、趋化因子受体、血管紧张素 2 型受体以及一些离子通道被发现具有镇痛作用，为开发新型镇痛药物提供可能性。

图表 7：阿片类镇痛药受体分类

Mu (μ)	Kappa (κ)	Delta (δ)
• 镇痛 • 欣快感 • 镇静 • 便秘 • 呼吸抑制 • 躯体依赖	• 镇痛 (内脏痛) • 镇静 • 呼吸困难 • 烦躁不安 • 呼吸抑制 • 躯体依赖	• 心理测量 (抗抑郁) 作用 • 烦躁不安 • 痛觉过敏

资料来源：海思精研微信公众号，华源证券研究所

图表 8：高效低毒阿片类镇痛药研发思路



资料来源：海思精研微信公众号，华源证券研究所

人福医药在传统麻醉优势基础上，持续开发低成瘾性镇痛药物，目前有：1）RFUS-144（外周 κ 阿片受体选择性激动剂）国内处于临床二期；2）HW231019（电压门控钠离子通道抑制剂），国内处于临床一期；3）RFUS-949（Sigma-1 受体特异性拮抗剂），国内处于临床一期；4）RFUS-250（KOR、MOR、DOR 受体激动剂）国内处于临床一期；5）LL-50（钠离子通道阻滞剂）国内处于临床一期；6）CXJM-66（钠离子通道阻断剂）国内处于临床一期。

以进展最快的 RFUS-144 为例，其聚焦外周 κ 阿片受体激动剂，对比常用的 μ 阿片类受体类药物（如芬太尼等）， κ 阿片受体成瘾性较低，RFUS-144 已在中美同步推进临床（中国 II 期/2023 年美国获批临床），其高选择性 κ 阿片受体设计可有效解决镇痛与成瘾性、呼吸抑制的矛盾。海思科的 HSK21542（思舒静）于 2025 年 5 月获批上市，是全球首个获批镇痛的高选择性外周 κ 受体激动剂。

1.3. 布局肺纤维化新靶点，竞争格局好

自分泌运动因子（Autotaxin, ATX）在肺纤维化中扮演关键角色，它催化产生溶血磷脂酸（LPA），LPA 能够强力激活肺成纤维细胞，促使细胞增殖、迁移和细胞外基质过度沉积，从而驱动肺纤维化的发生和进展。

图表 9：Autotaxin 作用机制

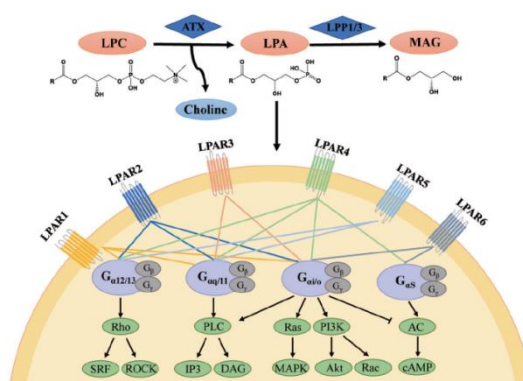


Figure 1 Main extracellular generation and action pathways of LPA. LPA: Lysophosphatidic acids; LPC: Lyso-phosphatidylcholine; MAG: Monoacylglycerol; ATX: Autotaxin; LPP: Lipid phosphate phosphatase

资料来源：《以自分泌运动因子-溶血磷脂酸轴为靶点的抗肺纤维化药物研发进展》江海燕等，华源证券研究所

在 ATX 抑制剂治疗肺纤维化研发领域，人福医药的 HW021199 进展较快，已推进至 II 期临床，海思科的 FTP198、恒诺康的 HNC664(中美双 I 期)及爱科百发的 AK0707 处于 I 期临床阶段，整体来看，全球基于 ATX 靶点治疗肺纤维化的研发管线相对较少，竞争格局良好。

图表 10：目前 Autotaxin 抑制剂药物竞争格局（截至 2025 年 8 月）

药品名称	作用机制	研发机构	疾病名称	中国最高研发阶段	中国研发阶段开始日期
HW021199	autotaxin 抑制剂	人福医药	特发性肺纤维化	II 期临床	2023-08-16
FTP198	autotaxin 抑制剂	海思科	特发性肺纤维化	I 期临床	2020-12-03
HNC664	autotaxin 抑制剂	恒诺康	胰腺癌，特发性肺纤维化	I 期临床	2022-09-05
AK0707	autotaxin 抑制剂	Partex;爱科百发	特发性肺纤维化	I 期临床	2022-12-22
HNC1058	autotaxin 抑制剂	恒诺康	特发性肺纤维化	临床前	

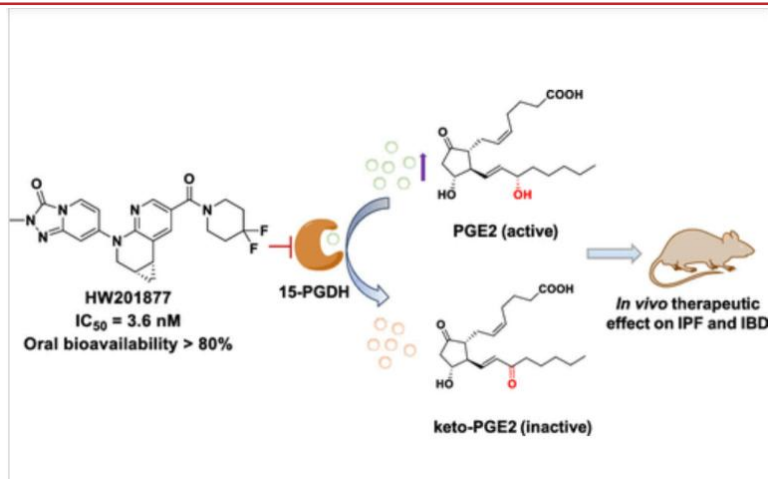
资料来源：医药魔方，华源证券研究所

1.4. 布局 15-PGDH 创新靶点，拓展炎症性肠病

HW201877 是人福医药自主研究的 1 类新药，为国内首款进入临床阶段的 15-PGDH 抑制剂，前列腺素 E2 (PGE2) 作为调控组织干细胞扩增和再生的关键脂质介质，是组织修复领域极具前景的治疗靶点。15-PGDH 是催化 PGE2 分解代谢的主要酶。研究发现，通过抑制 15-PGDH 活性，可有效提升内源性 PGE2 水平；升高的 PGE2 进而作用于其 G 蛋白偶联受体 (EP1-EP4)，激活下游信号通路，从而促进组织的修复与再生。

HW201877 为中国首个进入 I 期临床 (2025 年 3 月获批临床)，适应症为炎症性肠病，研发进度国内领先，其余企业如 Nimbus、Innovo 等均处于临床前探索。

图表 11：HW201877 作用机制



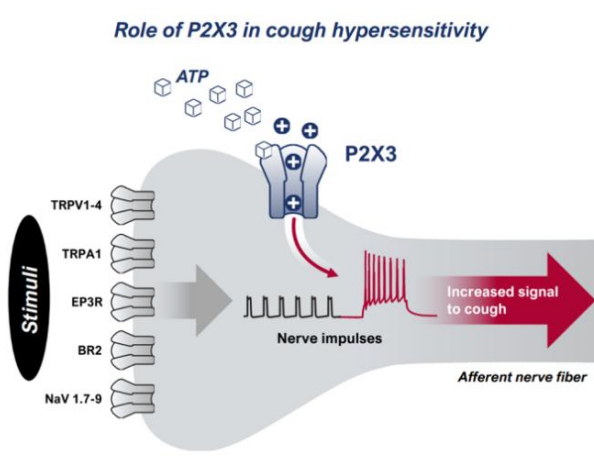
资料来源：《Discovery of HW201877: A Highly Potent and Orally Bioavailable 15-PGDH Inhibitor Promoting Tissue Repair and Regeneration》作者 Qun Li 等，华源证券研究所

1.5. P2X3 拮抗剂临床推进，布局难治性慢性咳嗽

人福医药填补常见病难治性慢性咳嗽（RCC）治疗空白，其 1 类新药 HW091077（P2X3 拮抗剂）以全新机制针对病因不明或现有治疗无效的 RCC 患者（约占慢性咳嗽患者的 8.4%），通过创新靶点调节气道高敏反应，解决传统疗法疗效不佳、易复发的临床痛点。HW091077 于 2023 年 10 月获批临床，目前处于一期临床阶段。

P2X3 是一种在外周神经元上表达的离子通道，会参与包括超敏反应、感觉传导在内的一系列复杂机制。目前已明确抑制 P2X3 靶点，可以起到减轻痛觉、抑制咳嗽、缓解神经性炎症等作用。

图表 12：P2X3 影响咳嗽机制

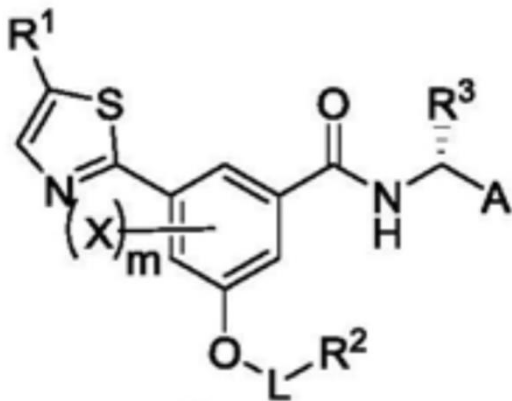


资料来源：中国医药创新促进会（药时代），华源证券研究所

目前市场上已有多家 MNC 布局 P2X3 拮抗剂，其中默沙东的 gefapixant 已完成三期临床，为该靶点临床最快，然而 gefapixant 由于疗效不显著未获得 FDA 批准上市。根据人福医药专利 CN114315818A，显示其拥有和默沙东完全不同的分子结构，或可降低其

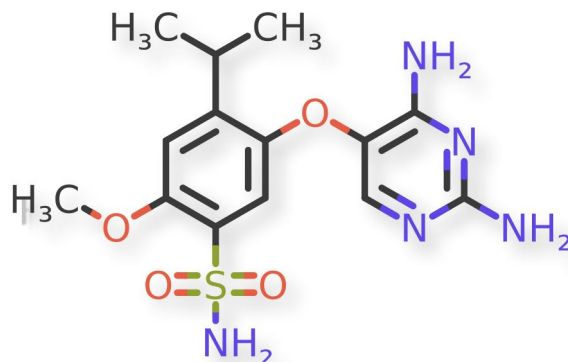
对味觉丧失的影响。

图表 13：人福医药专利 P2X3 拮抗剂分子结构



资料来源：人福医药专利 CN114315818A，华源证券研究所

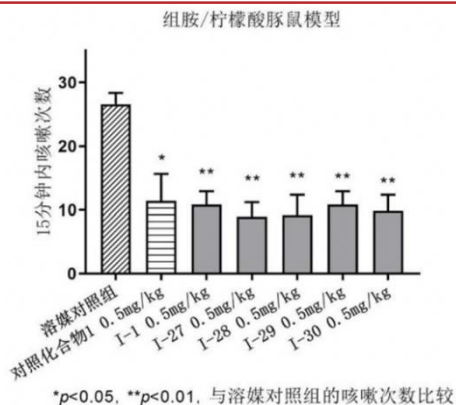
图表 14：默沙东 gefapixant 分子结构



资料来源：Precision FDA，华源证券研究所

人福医药在专利 CN114315818A 中显示其化学物及其变异体在组胺/柠檬酸引起的豚鼠咳嗽模型中有较为明显的咳嗽抑制效果(15 分钟内咳嗽次数从对照组的 26.6 次降低至 10 次左右，降低约 60%)；同时，在 ATP/柠檬酸引起的豚鼠咳嗽模型中有类似疗效(19.8 次降低至 7 次左右，降低约 65%)；在犬药物动力学中显示口服药物半衰期长达 13 小时，药物成药性好。

图表 15：人福医药 P2X3 拮抗剂临床前疗效



资料来源：人福医药专利 CN114315818A，华源证券研究所

1.6. 多款新靶点临床推进中，进军肿瘤广阔市场

人福医药布局多款抗肿瘤药物，包括：1) HWH340 (PARP 抑制剂) 国内临床二期；2) HW071021 (SOS1 抑制剂) 国内临床一期；3) HW060015 (EP4 抑制剂) 国内临床一期；4) 重组 TRAIL 国内临床一期；5) HWS116 (anti-FGFR2b 单抗) 国内获批临床。

除 PARP 抑制剂竞争较为激烈之外，公司其他管线竞争格局相对较为良好，如在 FGFR2b 靶向领域，其 anti-FGFR2b 单抗 HWS116 于 2025 年 4 月获批临床，同靶点

临床进度靠前的主要是再鼎医药贝玛妥珠单抗（III 期临床）及正大天晴 TQB2210（I 期临床）；SOS1 抑制剂 HW071021 于 2025 年 3 月开展 I 期临床，同靶点临床进度靠前的是泽璟制药的 ZG2001（I/II 期临床）与汇宇制药的 HYP-6589（I/II 期进度）等。

图表 16：目前 anti-FGFR2b 单抗药物竞争格局（截至 2025 年 8 月）

药品名称	作用机制	研发机构	疾病名称	中国最高研发阶段	中国研发阶段开始日期
贝玛妥珠单抗	anti-FGFR2b 单抗	再鼎医药;Five Prime Therapeutics	胃食管交界处癌, 胃癌, 食管癌, 实体瘤, 鳞状非小细胞肺癌, 非小细胞肺癌, 膀胱癌	III 期临床	2021-09-22
TQB2210	anti-FGFR2b 单抗	正大天晴	胃癌, 胃食管交界处癌, 癌症, 乳腺癌, 卵巢癌	I 期临床	2025-03-26
HWS116	anti-FGFR2b 单抗	人福医药	实体瘤	获批临床	2025-04-21

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

图表 17：目前 SOS1 抑制剂药物竞争格局（截至 2025 年 8 月）

药品名称	作用机制	研发机构	疾病名称	中国最高研发阶段	中国研发阶段开始日期
ZG2001	SOS1 抑制剂	泽璟制药	实体瘤	I/II 期临床	2023-06-14
HYP-6589	SOS1 抑制剂	汇宇制药	非小细胞肺癌, 实体瘤	I/II 期临床	2024-11-15
HW071021	SOS1 抑制剂	人福医药	实体瘤	I 期临床	2025-03-05
SYH2038	SOS1 抑制剂	石药集团	癌症, 实体瘤	申报临床	2023-09-14
SIM 0506	SOS1 抑制剂	先声药业	实体瘤	申报临床	2024-02-07
MRTX0902	SOS1 抑制剂	Mirati Therapeutics(BMS)	非小细胞肺癌, 结直肠癌	临床前	

资料来源：医药魔方，华源证券研究所

2. 行业观点：坚持创新药作为全年主线，关注制造出海+老龄化消费等估值相对低位资产

本周（8.25-8.29）、年初至今医药指数涨跌幅分别为-0.65%和 25.50%，相对沪深 300 指数的超额收益分别为-3.37%和 11.22%。

个股情况：本周上涨个股数量 101 家，下跌个股 385 家，涨幅居前为天臣医疗（+31.04%）、艾力斯（+25.62%）、迈威生物-U（+22.39%）、万邦德（+21.97%）、透景生命（+18.91%），跌幅居前为立方制药（-13.93%）、悦康药业（-11.90%）、康华生物（-11.14%）、辰欣药业（-11.10%）、皓宸医疗（-10.93%）。

图表 18：本周申万医药行业涨幅 Top10

排序	代码	名称	市值（亿元）	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	688013.SH	天臣医疗	45.4	31.04%	45.46%	231.70%
2	688578.SH	艾力斯	513.0	25.62%	17.28%	91.10%
3	688062.SH	迈威生物-U	191.8	22.39%	39.09%	137.62%
4	002082.SZ	万邦德	58.4	21.97%	26.32%	48.52%
5	300642.SZ	透景生命	50.2	18.91%	82.08%	121.06%
6	300111.SZ	向日葵	59.3	17.60%	30.97%	42.28%

7	835670.BJ	数字人	18.6	16.93%	17.32%	13.82%
8	688131.SH	皓元医药	145.2	16.36%	23.81%	92.54%
9	688331.SH	荣昌生物	509.3	15.14%	41.62%	201.83%
10	300357.SZ	我武生物	164.1	14.79%	23.67%	55.98%
11	801150.SI	医药生物(申万)		-0.65%	2.61%	25.50%
12	000300.SH	沪深 300		2.71%	10.33%	14.28%

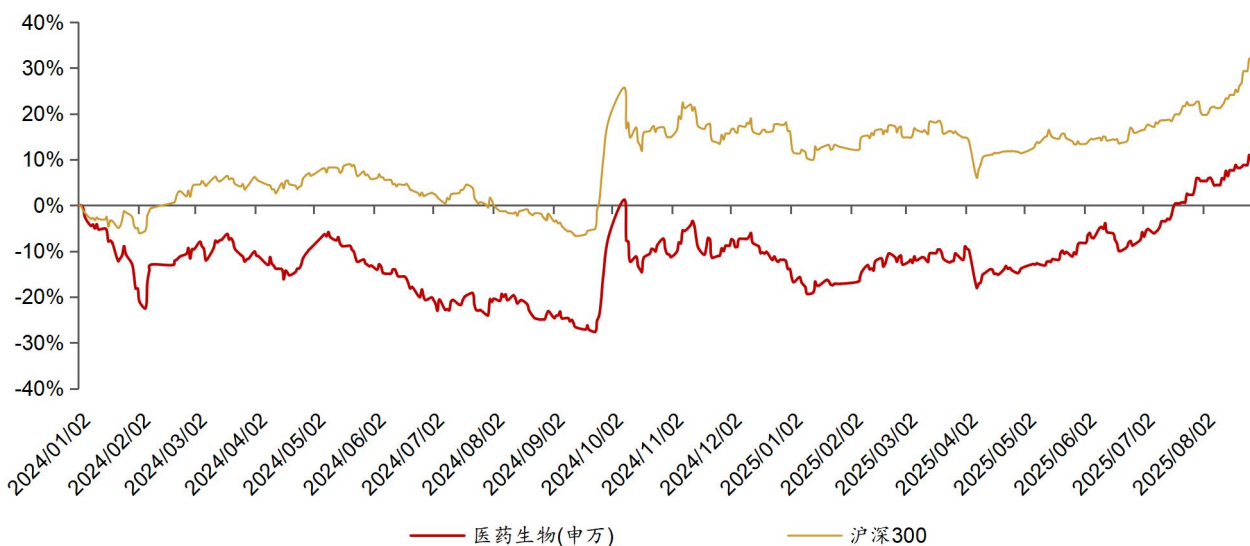
资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 19: 本周申万医药行业跌幅 Top10

排序	代码	名称	市值(亿元)	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	003020.SZ	立方制药	63.0	-13.93%	27.04%	87.95%
2	688658.SH	悦康药业	123.9	-11.90%	-12.16%	91.05%
3	300841.SZ	康华生物	97.9	-11.14%	-2.76%	40.80%
4	603367.SH	辰欣药业	115.3	-11.10%	-15.16%	88.19%
5	002622.SZ	皓宸医疗	31.5	-10.93%	25.00%	35.87%
6	300289.SZ	利德曼	44.8	-10.54%	16.90%	67.96%
7	688016.SH	心脉医疗	133.8	-10.34%	-1.51%	-0.78%
8	688277.SH	天智航-U	80.9	-10.34%	0.85%	78.88%
9	300583.SZ	赛托生物	30.8	-10.29%	-13.73%	-17.03%
10	688656.SH	浩欧博	78.5	-10.25%	-1.31%	29.95%
11	801150.SI	医药生物(申万)		-0.65%	2.61%	25.50%
12	000300.SH	沪深 300		2.71%	10.33%	14.28%

资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 20: 2024 年初至今医药指数表现



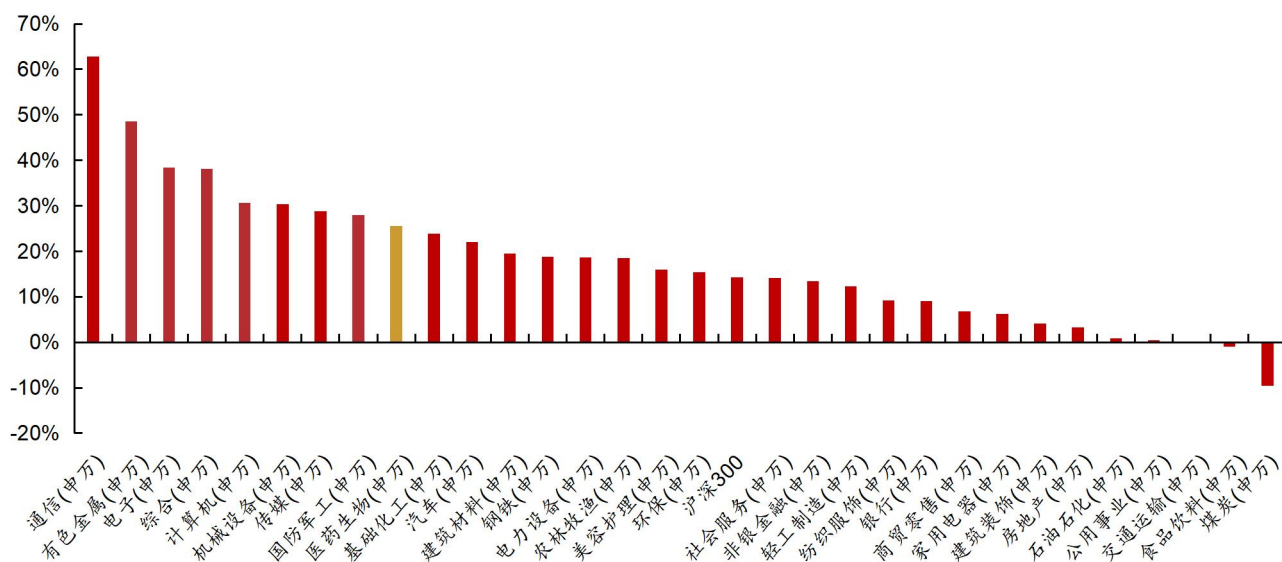
资料来源: Wind, 华源证券研究所

细分赛道涨跌幅情况:

本周，医疗服务Ⅱ（+3.1%）、化学制剂（-0.2%）、生物制品Ⅱ（-1.2%）、医疗器械Ⅱ（-1.6%）、中药Ⅱ（-2.3%）、医药商业Ⅱ（-2.5%）、化学原料药（-3.3%）。

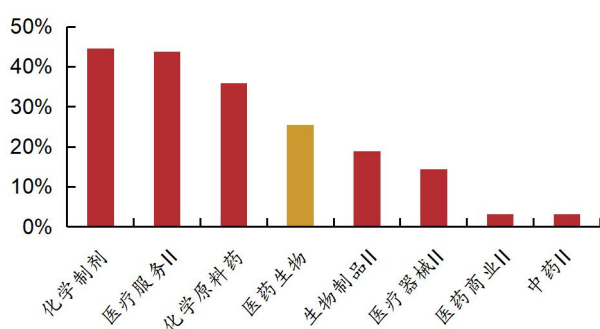
年初以来，化学制剂（+44.6%）、医疗服务Ⅱ（+43.7%）、化学原料药（+35.9%）、生物制品Ⅱ（+18.9%）、医疗器械Ⅱ（+14.5%）、医药商业Ⅱ（+3.2%）和中药Ⅱ（+3.1%）。

图表 21：申万各板块年初至今涨跌幅情况



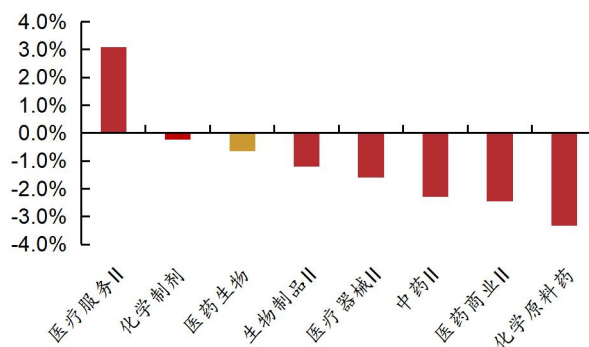
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 22：年初至今医药子板块涨跌幅情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

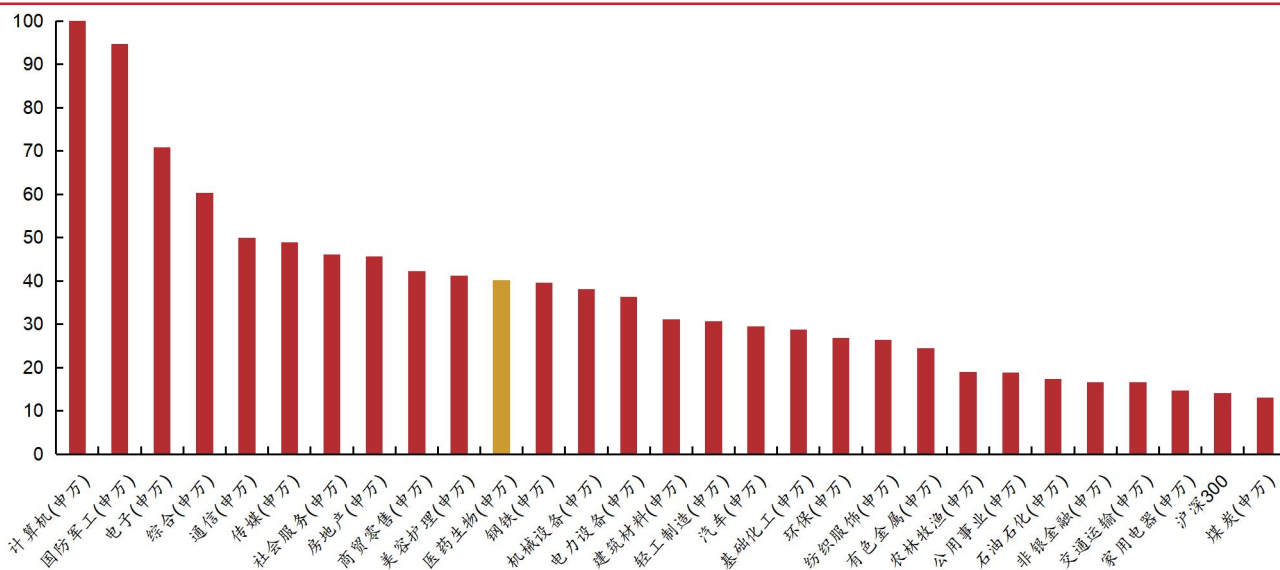
图表 23：本周医药子板块表现情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

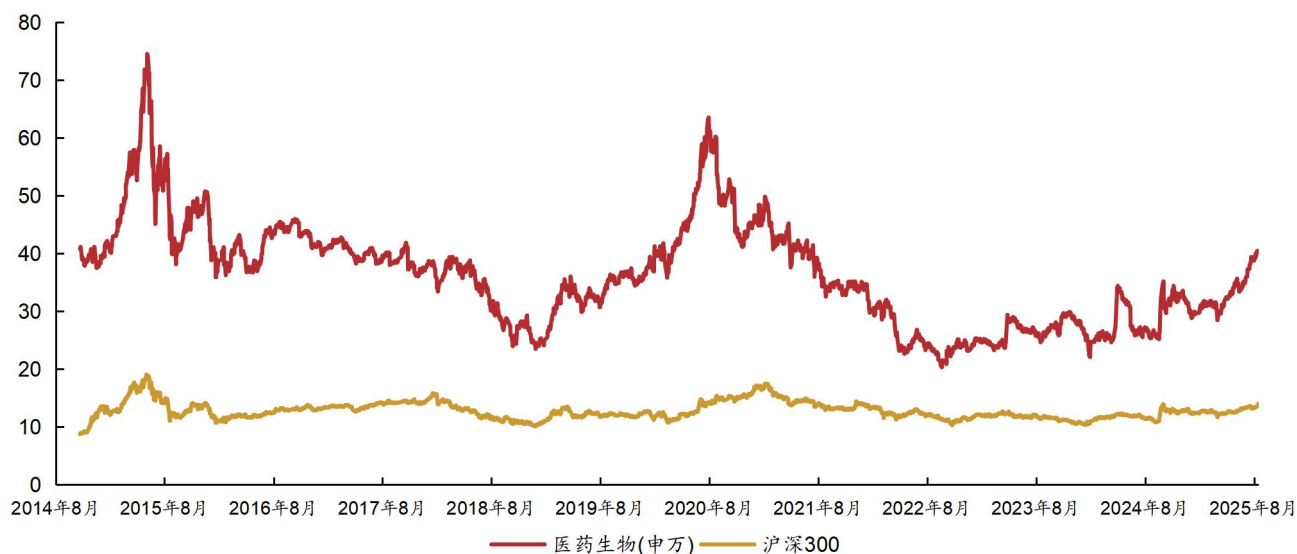
板块估值：截至 2025 年 8 月 29 日，申万医药板块整体 PE 估值为 40.20X，在申万一级分类中排第 11，从 PE 绝对值来看，目前医药估值仍在历史相对较低位置。各细分板块估值情况，目前化学制剂、化学原料药和生物制品Ⅱ等板块估值相对较高，中药和医药商业估值相对较低。

图表 24：申万各板块 PE 估值情况（截至 2025 年 8 月 29 日，整体 TTM 法）



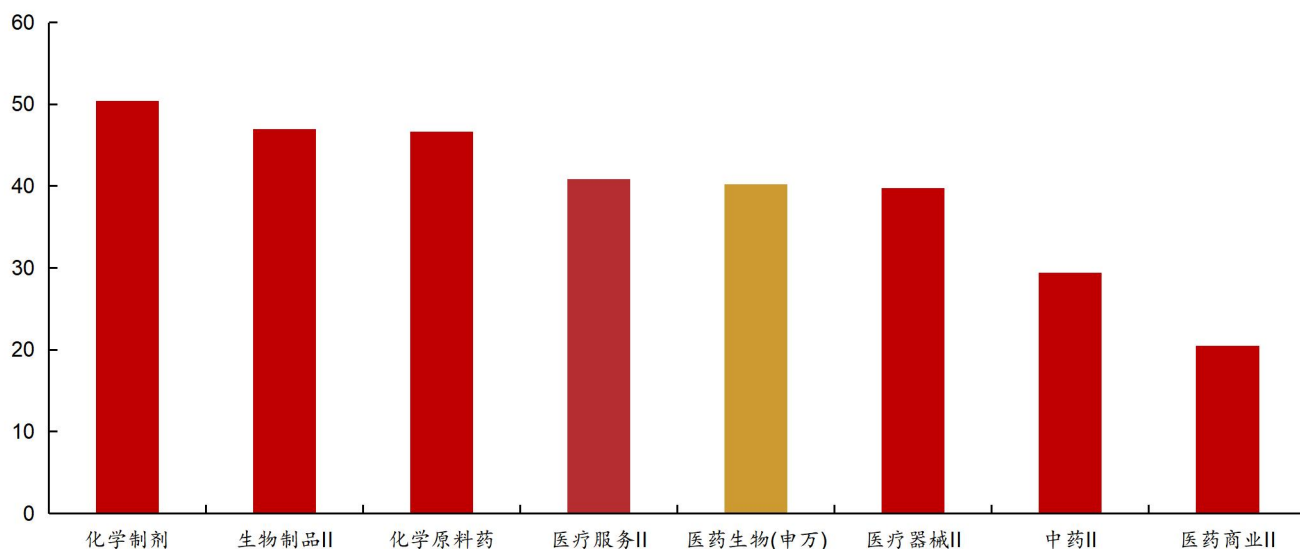
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 25：申万医药及沪深 300 PE 估值情况（截至 2025 年 8 月 29 日，整体 TTM 法）



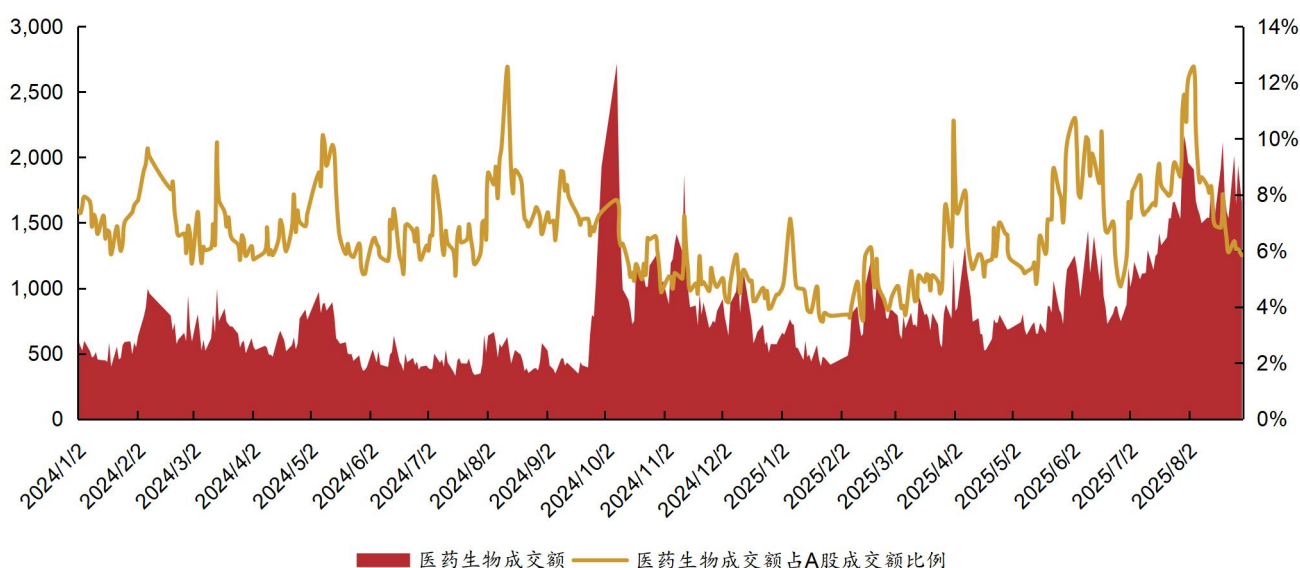
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 26: 申万医药各细分板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 8 月 29 日, 整体 TTM 法)



资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 27: 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例 (万亿)



资料来源: Wind, 华源证券研究所

投资观点: 2024 年医药行业已经呈现多重底, 医改影响或调整到位, 板块估值、持仓均处于近年来低位, 展望 2025 年, 我们认为行业在创新药的带领下有望迎来反弹, 医疗消费和医药制造业绩有望触底反弹, 估值或将逐步修复, 结构性行情或将持续演绎。医药行业已具备多方面的积极发展因素, 1) 创新产业已经初具规模, 多家公司的创新布局迎来收获, 传统 pharma 也已经完成创新的华丽转身, 中国创新药研发能力已跃居全球前列, 竞争力快速提升; 2) 出海能力持续提升, 创新药械的 license out 频频出现, 中国企业已成为全球 MNC 非常重视的创新转换来源; 3) 老龄化持续加速, 银发经济长坡厚雪; 4) 支付端看, 医保收支仍在

稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI 浪潮下，医药有望迎来新发展机遇，释放新的增长潜力。

整体来看，我们认为当前医改影响已调整到位，行业有望边际好转，看好 2025 年医药否极泰来，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。坚持“创新”作为全年维度的主线，关注下半年“出海+老龄化”等处于估值相对低位资产：

1) 创新药械及产业链：国务院明确表态支持创新药全产业链发展，多地陆续出台相关政策，出海 BD 规模持续创纪录，我们认为创新药/械及产业是较为明确的产业趋势，建议关注恒瑞医药、科伦药业、信立泰、科伦博泰、康方生物、翰森制药、中国生物制药、三生制药、信达生物、泽璟制药、热景生物、科兴制药、广生堂、赛诺医疗等。产业链方面，建议关注药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、泰格医药、百普赛斯、毕得医药等。

2) 制造出海：欧美占据全球医药主要市场份额，市场空间大，新兴市场正在快速发展，海外潜在增量十分可观，建议关注迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、鱼跃医疗、三诺生物、美好医疗、海泰新光等。

3) 国产替代：国产替代依旧是未来几年较为确定的产业趋势，其中内窥镜、微电生理等市场空间大、竞争格局好、国产率低，主要建议关注开立医疗、澳华内镜、惠泰医疗、微电生理等。

4) 老龄化及院外消费：随着 50 岁以上的老年化群体持续扩大，相关的健康消费需求有望稳步增长，建议关注昆药集团、鱼跃医疗、可孚医疗、华润三九、同仁堂、马应龙、羚锐制药、盘龙药业等。

5) 高壁垒行业：麻药和血制品行业需求较为稳健，供给端相对稳定，建议关注麻药（人福医药、恩华药业、国药股份等）、血制品（派林生物、天坛生物、博雅生物等）。

6) AI 主线或有望贯穿 2025 年，医药相关板块和个股有望反复表现，建议关注制药（晶泰控股、泓博医药）、大数据模型（润达医疗、美年健康、金域医学、医脉通、阿里健康、华大基因）、医疗设备（鱼跃医疗、三诺生物、联影医疗、开立医疗、华大智造）等。

本周建议关注组合：信立泰、上海谊众、前沿生物、热景生物、中国生物制药；

九月建议关注组合：恒瑞医药，信立泰，科伦药业，康弘药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，三生制药，上海谊众，前沿生物。

3. 风险提示

1) 行业竞争加剧风险：随着我国医药产业的不断创新与进步，不排除持续有新进竞争者加入从而造成竞争加剧的风险；

2) 政策变化风险：分级诊疗、医保支付改革持续成为医改重心，医保控费大趋势、带量采购等让医药产业中下游的收入利润有承压风险；

3) 行业需求不及预期风险：若终端需求不及预期，将会对公司业绩产生负面影响。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数。